**جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *** **طلب علاج أول مرة / متردد**

**إسم المريض رباعياً :** عبير جمال حسين حسن
**المحافظة :** جنوب سيناء **الحي / المدينة :** طور سيناء **العنوان :** 4ال720وحده
**رقم البطاقة :** 28207272200423 **رقم التليفون :** 01013686665 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 10-10-2026
**العمر(تاريخ الميلاد) :** 27-07-1982 **المهنة :** حاصل علي دبلوم

**التشخيص الإكلينيكي :** سرطان بالثدي (مبادرة)
**نتائج الأبحاث :** (مرفق)
**التشخيص النهائي :** سرطان بالثدي (مبادرة)
**خطة العلاج :** علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
**التعليق على التشخيص :** ----------

**خطاب إداري**

**هذا الرقم القومي يتبع منظومة التأمين الصحي الشامل جهة الاختصاص**

جوستاف روسي - مصر

**Name:** عبير جمال حسين حسن
**National ID:** 28207272200423

## تقرير طبي

**السيد**

**تحية طيبة وبعد,,**

| | |
|---|---|
| **إيماء للطلب المقدم من** | **بشأن تقرير طبي للمريض** |
| **بقسم:** | **رقم طبي:** |

**نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته**

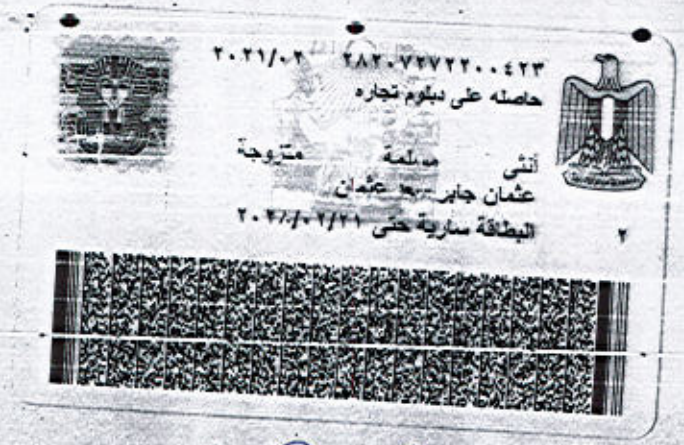
| | |
|---|---|
| **تاريخ وساعة الدخول :** -- --:-- yyyy-mm-dd | **تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026 |

**وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة**

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

| | |
|---|---|
| **التاريخ :** 05-07-2026 | **الوقت :** -- --:-- |
| | **الطبيب المعالج :** د/شيماء لاشين |




ومن
انجا شوفوها
ام اميرة
عاقل + ثورك

Oncology Center
مركز الأورام

وزارة الصحة
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى معهد ناصر
Nasser Institute Hospital

NASSER INSTITUTE
ONCOLOGY CENTER
معهد ناصر
مركز الأورام

NUCLEAR MEDICINE UNIT
وحدة الطب النووي

***Patient Name: Abeer Gamal*** ***Date: 10/12/2020***
***Referring physician: Prof.***

# $^{99m}$Tc-MDP BONE SCAN

**Desired information :** skeletal surveying to detect multiple lesions.

**Technique:** Anterior and posterior whole body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi $^{99m}$Tc-MDP.

**Report:**

- No definite hot spot that account for osseous deposits could be detected allover the surveyed skeleton.
- Degenertaive changes are noted in the dorso-lumbar vertebrae.
- Both kidneys are normally seen

**Conclusion:**

- No definite evidence of metatstatic osseous deposits.

**Thanks for reference**

**Nuclear Medicine Unit**

***Magdy Kotb, M.D.***

١٣٥١ كورنيش النيل - أغاخان - شبرا - القاهرة ت : ٢٢٠٣٩١٦٤ - ٢٢٠٣٩٣٥٦ فاكس : ٢٢٠٢٩٢٢٦
1351Korniesh El Nile - Aghakhan - Shoubra - Cairo Tel.: 22039164 - 22039356 Fax : 22039 236

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

| | |
|---|---|
| **Name:** عبير جمال حسين حسن<br>**MR. :** 3645 | |

Detailed Medical Report

| | |
|---|---|
| **السيد** | |

**تحية طيبة وبعد,,**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **إيماء للطلب المقدم من** | | **بشأن تقرير طبي للمريض** | |
| **بقسم:** | | **رقم طبي:** | |

**ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تاريخ وساعة الدخول :** | | **تاريخ وساعة الخروج :** | |

**وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه**

**The patient underwent right modified radical mastectomy with reconstruction on 12/02/2020 for a right breast carcinoma staged as pT2N2M0 (4 of 16 lymph nodes positive). Pathology demonstrated estrogen receptor positivity in 7 of 8 cores, progesterone receptor negativity (0/8), and HER2 negativity. The patient completed adjuvant chemotherapy consisting of four cycles of doxorubicin and cyclophosphamide followed by four cycles of a taxane (4 AC → 4 T) and subsequently received postoperative radiation therapy. Since December 2020, the patient has been on ovarian function suppression with Zoladex combined with the aromatase inhibitor Arimidex for three months, with ongoing endocrine therapy.**

**A bone scan performed on 18/04/2026 revealed an equivocal active osseous lesion in the left supra-orbital region. The plan is to follow this finding after three months while continuing Arimidex plus supplemental therapy for three months.**

**The patient is a 43-year-old premenopausal female with right breast cancer (ER 7/8, PR 0/8, HER2−). After completing the aforementioned surgery, adjuvant chemotherapy, and radiation, she has been receiving Zoladex and Arimidex since December 2020. The recommendation is to discontinue Zoladex now that she has completed more than five years of ovarian function suppression, and to check serum estradiol and FSH after stopping ovarian suppression, repeating these labs every three months until menopausal status is confirmed. If ovarian function recovers (premenopausal), the aromatase inhibitor should be stopped and tamoxifen initiated to complete extended endocrine therapy; if the patient becomes postmenopausal, continuation of letrozole (Femara) as extended endocrine therapy is advised.**

**A brain CT performed in August 2026 was negative for disease. The patient will continue Arimidex plus supplemental therapy for three months, and the next follow-up visit is scheduled for 28/11/2026.**

**تحريرا في ,**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **التاريخ :** | **18-09-2026** | **الوقت :** | |

**الطبيب المعالج :** **dina makram**

**يعتمد ,**

امانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
إداره المعمل
قسم البالولوجي

# Pathology Report

Name: عبير جمال حسين Age: 55 years.

Clinical data: Right breast mass.

Specimen type: wide local excision , axillary clearance, wedge resection from nipple

Date: 12/2/2020

Lab. Number: 247 Hospital Number: مبادرة /2019

## Gross Description:

Three specimens were received:

1) Right breast mass excision; a fibro-fatty tissue piece; 5.5x4x2 cm. Cut sections revealed an ill-defined greyish white rubbery to firm mass; 5x4x2 cm.

2) Axillary clearance measured; 6x4 cm, enclosing; 16 nodules, up to 1.5 cm.

3) Nipple wedge biopsy; a greyish white tissue piece; 1x0.5 cm, totally submitted.

## Microscopic Examination:

Histopathological examination of sections prepared from the lumpectomy specimen received reveals an infiltrating malignant epithelial growth. The tumour is made up of groups and small sheets of pleomorphic hyperchromatic malignant ductal epithelial cells with micropapillary features. Stromal desmoplasia is moderate. Cellular and nuclear atypia are moderate. Intraduct component is 15% comedo and non comedo. Scattered lymphovascular embbli. No perineural invasion.

Surgical margins are free.

LN 4/16 with no extranodal extension.

Nipple shows paget's disease.

## Diagnosis:

- **Invasive duct carcinoma GII, with micro-papillary features.**
- **In situ comedo, non-comedo 15%.**
- **No perineural invasion.**
- **Positive lymphovascular.**
- **Free surgical margins.**
- **Lymph nodes 4/16 with no extranodal extension.**
- **Nipple, paget's disease of the nipple.**
- **Stage pT2 pN2a.**

*Prof. Dr. Lubna Omar*

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]